

BANTUAN HIDUP DASAR (BHD)

RSUD CIPAYUNG

JANUARI 2019

APA ITU BHD?

BHD (Bantuan Hidup Dasar) adalah Pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas kesehatan.

-American Heart Assosiation 2015



KENAPA BHD PENTING?

- Kematian akibat penyakit jantung paling utama NOMOR 1 DI DUNIA disebabkan karena henti jantung mendadak.
- Otak dan jantung merupakan organ vital. Jika dalam <8 detik tidak mendapat oksigen akan mengalami kematian sel.

Keterlambatan BHD

1 menit
3 menit
10 menit

Kemungkinan berhasil

98 dari 100
50 dari 100
1 dari 100

- BHD harus dapat dilakukan oleh SEMUA ORANG, DIMANAPUN dan KAPANPUN !



KAPAN BHD DIBERIKAN ?

- **Henti Nafas**

Ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan dari korban/pasien.



- **Henti Jantung**

Terhentinya sirkulasi yang dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen.



Syarat dasar untuk hidup

```
graph TD; A[Syarat dasar untuk hidup] --> B[Fungsi Peredaran Darah]; A --> C[Fungsi Pernapasan]; B --> D[Terganggu]; C --> E[Terganggu]; D --> F[Henti Jantung]; E --> G[Henti Napas]; F <--> G;
```

**Fungsi
Peredaran Darah**

**Fungsi
Pernapasan**

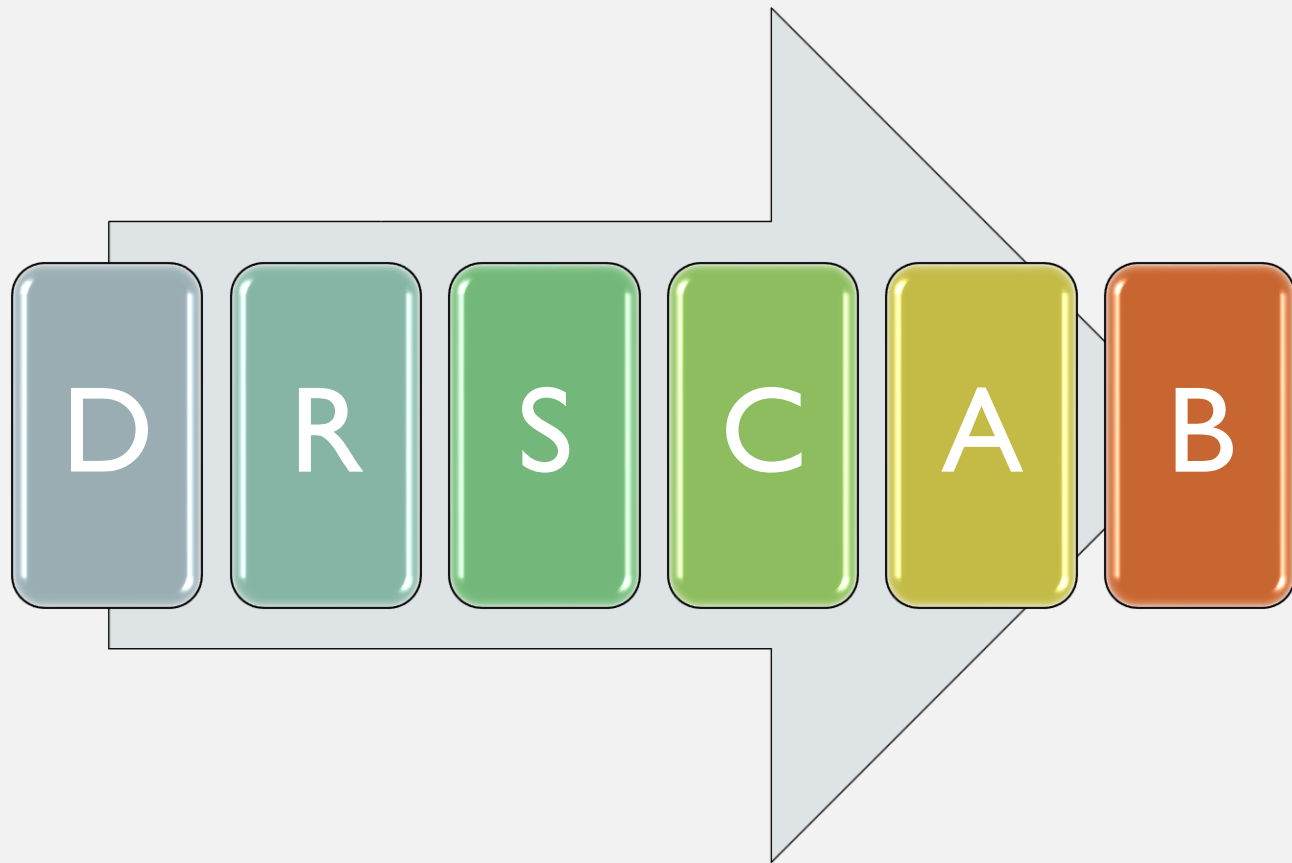
Terganggu

Terganggu

Henti Jantung

Henti Napas

ALGORITMA BANTUAN HIDUP DASAR



CPR is as easy as **C-A-B**



Compressions

Push hard and fast
on the center of
the victim's chest



Airway

Tilt the victim's head
back and lift the chin
to open the airway



Breathing

Give mouth-to-mouth
rescue breaths



DANGER (BAHAYA)

PASTIKAN KEAMANAN

3A

Aman Penolong

Aman Pasien

Aman Lingkungan



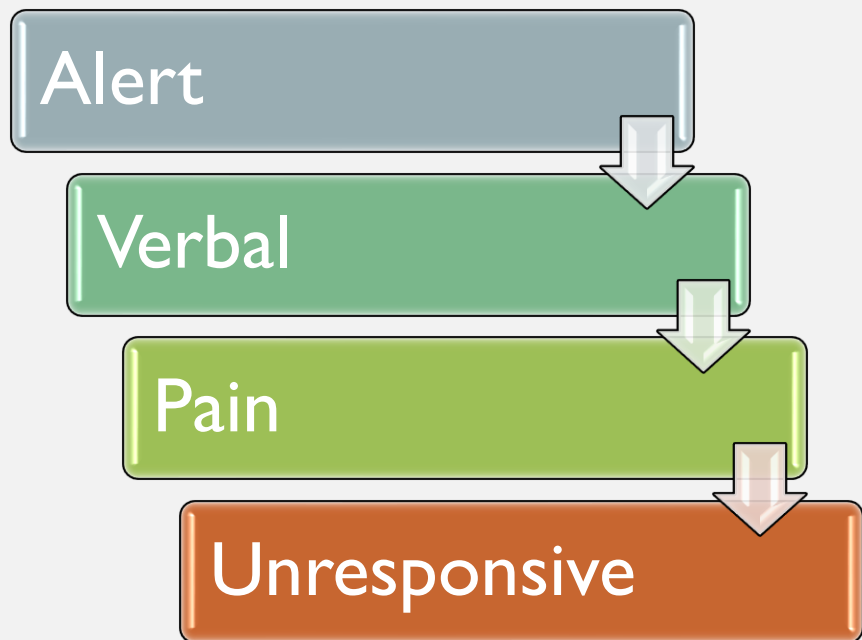
Menggunakan Sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya

RESPONSE (RESPONS)

Cek Respon Korban



Teriak, panggil, tebak bahu dan
beri rangsangan nyeri



**Hati-hati, kemungkinan terjadi
trauma servikal**

SHOUT FOR HELP (MEMINTA PERTOLONGAN)



Meminta bantuan, sambil tetap bersama korban

- Tetap bersama korban, gunakan **handpone** untuk panggil bantuan, aktifkan speaker untuk berkomunikasi dengan mendengarkan instruksi tenaga kesehatan

Atau

- Jika sendirian tanpa **Handphone**, berteriak meminta tolong dan ambil **AED** (jika dapat segera tersedia) sebelum melakukan **RJP**

NOMOR TELEPON DARURAT

- **Polisi** 110
- **Ambulans** 119
- **SAR** 115
- **Posko bencana alam** 129
- **PLN** 123
- **Pemadam kebakaran** 113
- **SPGDT** 119
- **Jakarta Siaga** 112





CIRCULATION (SIRKULASI)



Meraba nadi karotis, 2-3 cm dari
samping trakhea

- Cek Nafas dan Nadi **bersamaan** kurang dari 10 detik

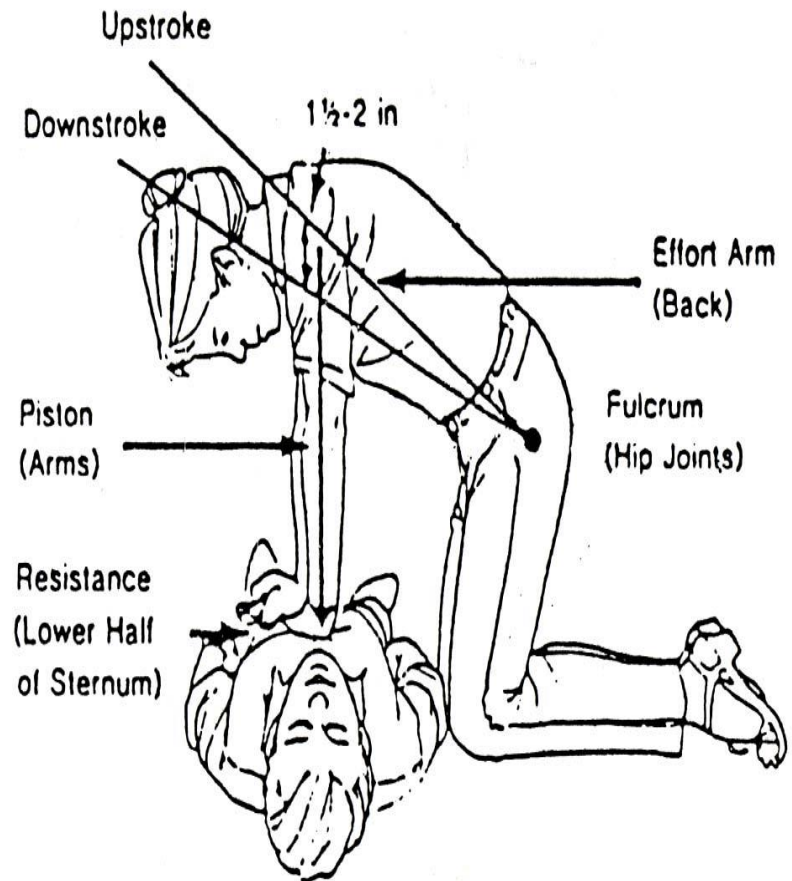
Atau

- Jika nadi tidak teraba,
- **beri 30 kompresi : 2 ventilasi**
- Jika nadi teraba,
- **beri 1 ventilasi setiap 6 detik (10 kali / menit)**

KOMPRESI DADA RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)



Rasio kompresi jantung : nafas buatan
30 : 2 sebanyak 5 siklus (2 menit)



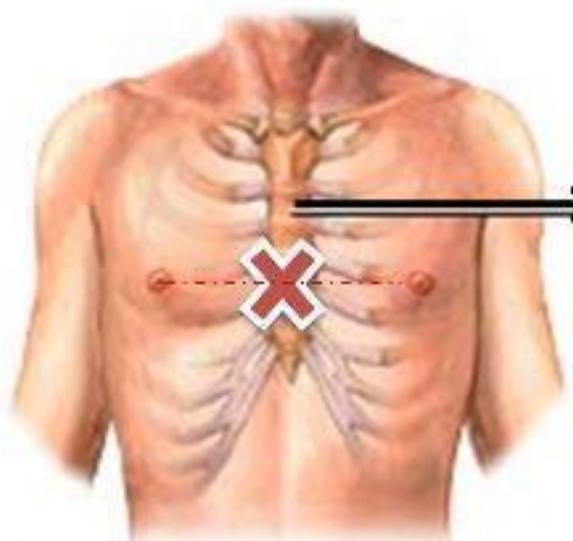
KOMPRESI DADA YANG BENAR



Posisi tangan pada
lower half of sternum

Atur Posisi :

- Pasien terlentang diatas permukaan yang keras & datar
- **Posisi penolong** : berlutut di samping pasien / berdiri disamping dada pasien
- Letakan tumit telapak tangan pada **Pertengahan dada (seperdua bawah sternum)** dengan kedua telapak tangan di tumpuk dan dikaitkan



Pompa diberikan pada pertengahan bawah tulang dada, sejajar puting susu pada pria

Yang menjadi tumpuan adalah tumit telapak tangan

Pompa diberikan dengan kecepatan 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm

Posisi telapak tangan, siku, lengan atas, dan bahu sejajar



POSISI JARI PADA KOMPRESI DADA BAYI/ANAK



SYARAT KOMPRESI DADA YANG BAIK

- **Kompresi jantung : nafas buatan = 30 : 2**
- Kecepatan kompresi 100 – 120 x/ menit
- Selalu berikan kesempatan untuk rekoil dada sempurna
- Sedalam 5-6 cm pada dewasa, 2-3cm pada bayi/ anak
- Dilakukan 5 siklus (2 menit) lalu evaluasi, bila masih henti jantung/ nafas lanjut RJP
- Minimal Interupsi

AIRWAY (JALUR PERNAPASAN)



Mendengkur
(pangkal lidah jatuh)

Suara berkumur
(cairan)

Stridor (pita suara
bengkak)

HEAD TILT & CHIN LIFT (TEKAN DAHI & ANGKAT DAGU)

TEKAN
DAHI

ANGKAT
DAGU



Jika tidak ada **kecurigaan cedera tulang leher**

JAW TRUST (ANGKAT DAGU)

ANGKAT
DAGU



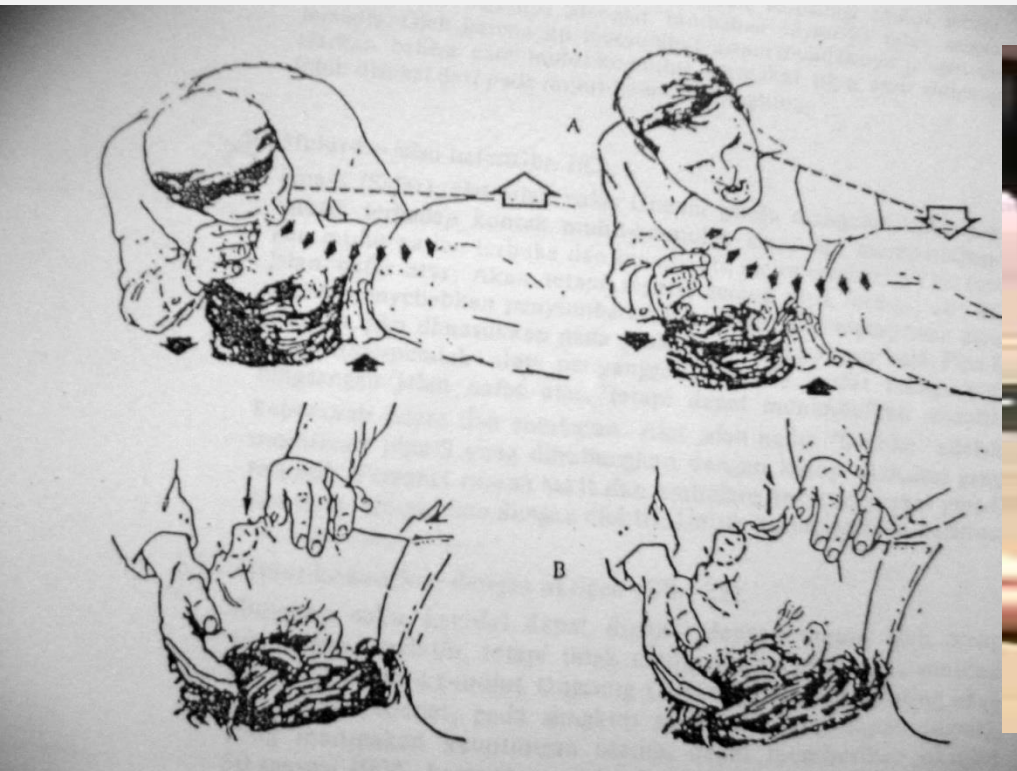
Jika ada kecurigaan cedera tulang leher

BREATHING (PERNAPASAN)



Look, listen and
feel for breathing

**2X NAFAS BUATAN DILAKUKAN
DALAM <10 DETIK**



EVALUASI

- **Evaluasi dilakukan tiap 2 menit/ 5 siklus :**
- Jika nafas (-) dan nadi (-), kompresi dan ventilasi 30 : 2
- Jika nafas (-) dan nadi (+), ventilasi 10 kali per menit
- Jika nafas (+) dan nadi (+), Berikan **recovery position**



RECOVERY POSITION (POSISI MANTAP)

POST-CPR RECOVERY POSITION

1. Bend one arm and keep legs straight.



2. Place back of victim's hand against cheek and hold there.



3. Hold victim's hand against cheek to support head.



Pull bent leg and roll victim toward you.

4. Hand supports head. Bent knee prevents rolling. Bent arm gives stability.

Front view of recovery position



KAPAN BHD DIHENTIKAN?

- Pasien sadar / kembalinya ventilasi & sirkulasi spontan
- Penolong sudah datang
- Penolong lelah / 30 menit tidak ada respon
- Adanya DNR (Do Not Resuscitation)
- Tanda kematian yang irreversibel



LEBAM MAYAT



KAKU MAYAT



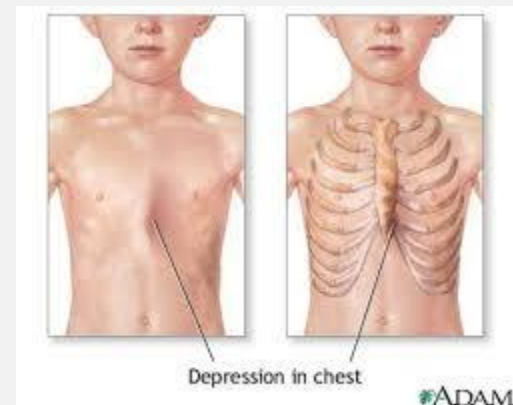
KAPAN BHD TIDAK DILAKUKAN ?

- **DNR (Do Not Resuscitation)**
- **Tanda kematian : lebam mayat, kaku mayat**
- **Bila menolong korban akan membahayakan penolong**



APA KOMPLIKASI BHD ?

- Patah tulang iga/ sternum
- Pneumothorax
- Hemothorax
- Kontusio paru
- Luka hati dan limpa, posisi tangan yang terlalu rendah akan menekan processus xipioideus ke arah hepar (limpa)



AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)





Thank
you!!

